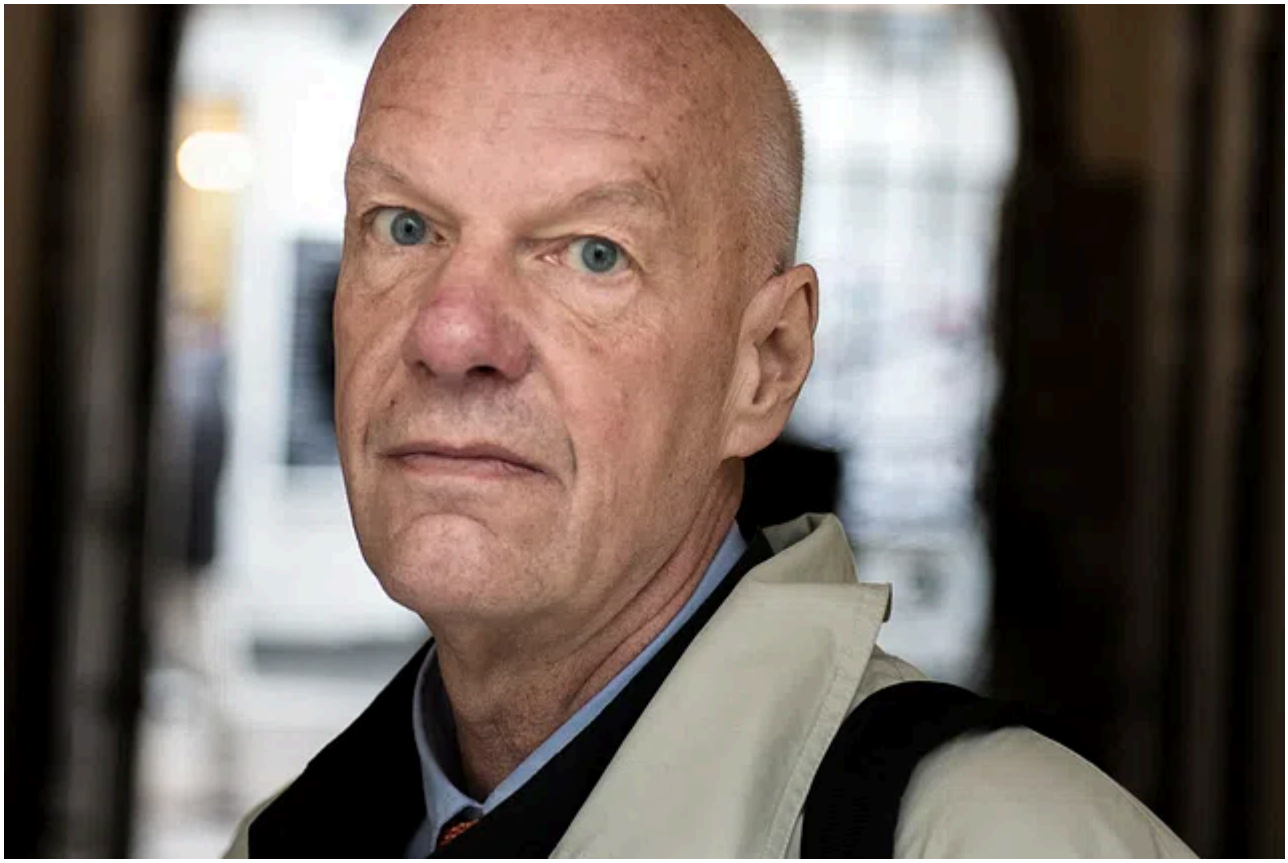
Är vi kloka nog för genteknik?

OMÖJLIGA VAL De etiska frågorna kring gentekniken diskuteras för lite, tycker Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och sakkunnig inom Statens medicinsk-etiska råd. Han varnar för att ett rasbiologiskt tänkande kan uppstå bakvägen.

Publicerad 2014-06-03



”Hur blir det när det i förväg går att ta reda på vem som kommer att drabbas av sjukdom?”, undrar Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och sakkunnig inom Statens medicinsk-etiska råd. Kommer vi då att känna oss tvingade att välja bort ett sådant foster? Foto: YVONNE ÅSELL

–**Gendiagnostikens** snabba utveckling kräver eftertanke. Den saknas i dag, säger Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och sakkunnig inom Statens medicinsk-etiska råd.

Han nämner uttrycket ”the backdoor to eugenics”, rashygien bakvägen, något som diskuteras inom medicinsk-etisk forskning.

– Rasbiologi förknippas med ett samhälle som driver en medveten strategi att rensa bort vissa individer. Det har vi inte. Men allt fler valmöjligheter läggs i individens händer. Vi kan med genetikens hjälp till exempel välja, eller välja bort, vissa egenskaper hos ett foster. På så vis kan ett rasbiologiskt tänkande uppstå bakvägen, även om samhället är emot den utvecklingen och det inte finns någon galen ledare som driver på.

Nils-Eric Sahlin tror inte att vi människor är så kloka. Vi tänker kortsiktigt och strävar efter en perfekt yta att visa upp. Om tekniken ger föräldrar möjlighet att inom en snar framtid välja bort ett foster med oönskade egenskaper så befarar han att de gör det. Fyra fingrar på vänster hand, eller ett foster som kommer att bli väldigt kort eller väldigt långt räcker kanske för att välja bort det.

Möjligheterna leder till en jakt efter det felfria barnet. Vad är ett felfritt barn? Vilka egenskaper är viktiga? Hur ska samhället förhålla sig till den grundläggande rätten till fri abort om allt fler foster väljs bort av sådana kosmetiska skäl, frågar han sig.

– Ju mer förfinade metoder som utvecklas, desto mer av denna typ av etiska frågor måste synliggöras, menar Nils-Eric Sahlin.

Han betonar att svaren inte är enkla. Möjligheterna med tekniken minskar lidande och sjukdom. Men om inte frågorna om teknikens nackdelar ställs i tid finns risken för oönskade konsekvenser. De flesta foster med Downs syndrom aborteras. Vad innebär det för de människor som i vår tid lever med dessa kromosomförändringar, liksom för deras anhöriga?

– Fosterdiagnostiken gör att vi väljer bort redan i dag, på gott och ont. Men risken är att den genetiska diagnostiken i allt ökande omfattning kommer att användas som en selektionsmetod. Hur belastande ska en sjukdom vara för att ett foster väljs bort? Det finns en stor risk att samhällets grundläggande idé om lika människovärde hamnar i skymundan.

Det svenska sjukvårdssystemet bygger på att vi gemensamt bidrar till det via skatter.

– Hittills har vi människor fötts utan att någon kunnat säga vilka sjukdomar vi kommer att få i framtiden. Det har varit en anledning till att alla solidariskt bidragit. Hur blir det i framtiden när det i förväg går att ta reda på vem som kommer att drabbas av sjukdom eller handikappande tillstånd? Är vi då lika intresserade av att bidra, när det hade kunnat gå att undvika kostnader genom att välja bort fostren?

Nils-Eric Sahlin ställer frågorna på sin spets och påminner också om kommersiella aspekter på genteknikområdet. Han nämner privata företag i USA som erbjuder tester där en persons hela DNA-uppsättning presenteras. Vad gör en människa med sådan information och med ett oönskat resultat hon inte hade räknat med? Företagen tar inte ansvar för konsekvenserna. I stället blir det sjukvården som får ta emot patienternas oro, även när det inte handlar om svåra sjukdomar som kräver omedelbara insatser.

– Frågan är hur vi prioriterar de sjukvårdsresurser vi har. Gentesterna kommer troligen att öka trycket på vården, de skapar nya behov hos patienterna. Men eftersom pengarna inte räcker till allt innebär det att andra patientgrupper får stå tillbaka, som till exempel de äldre och sköra, en grupp som växer men inte hörs.

Det etiska samtalet uteblir, konstaterar han. Kanske för att utvecklingen inom området känns som science fiction, att frågorna är känsliga och ställer grundläggande principer på sin spets, eller för att många helt enkelt inte bryr sig, gissar han. De tekniska och medicinska möjligheterna lyfts fram, medan de etiska aspekterna hamnar i bakvattnet.

– Frågorna *måste* diskuteras. Annars får vi ett enormt godtycke, varnar etikprofessorn.

Eva Bergstedt